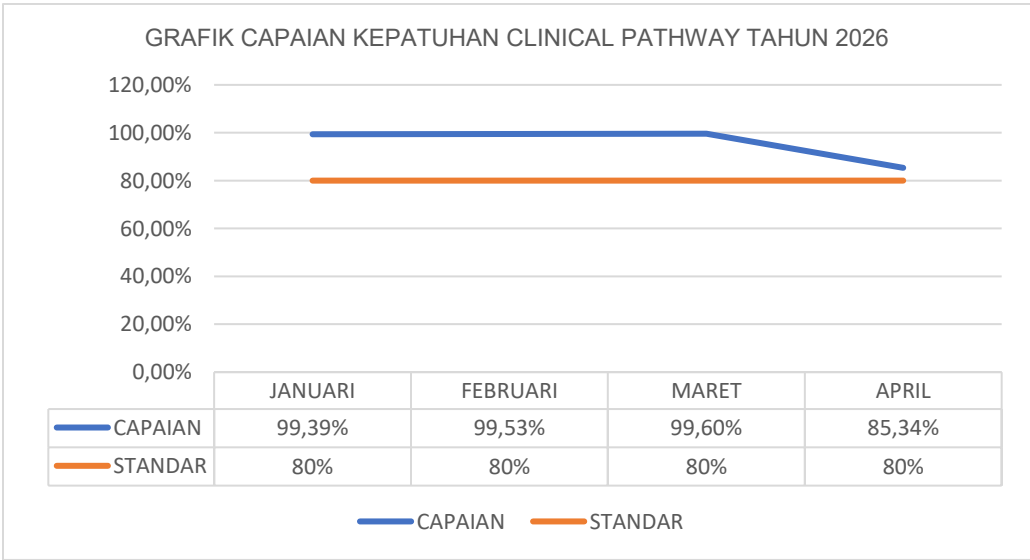


EVALUASI KEPATUHAN PPK DAN CP BULAN APRIL 2026
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

A. KEPATUHAN CLINICAL PATHWAY



Analisis :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada bulan April 2026 telah mencapai standar yakni 85,34%. Angka tersebut sudah mencapai target 80%. Adapun kriteria yang diukur Adalah LOS (Length of Stay), Asesmen Klinis, Pemeriksaan Penunjang, Obat yang diberikan kepada pasien, Asesmen Keperawatan, Asesmen Gizi dan Asesmen Farmasi. Clinical Pathway Bulan April didapatkan dari Diagnosa PEB, Partus Prematurus, Secsio Secaria, TB Paru, Pneumonia, Bacterial Pneumonia, Tifoid dan Bronchopneumonia

B. EVALUASI

1. Pneumonia Dewasa

- a. *Length of Stay* bervariasi antara 3-5 hari untuk pasien dengan diagnosis utama Pneumonia tanpa komplikasi
- b. *Length of stay* memanjang >5 hari pada pasien pneumonia dengan komplikasi (CKD, gagal napas, CVA, pasien operatif)
- c. Penggunaan Antibiotik sudah sesuai dengan CP : Inj Ceftriaxone dan Levofloxacin tab bila diperlukan. Durasi pemberian antibiotik injeksi sudah sesuai minimal 72 jam selama rawat inap.
- d. Pemeriksaan sputum gram belum sepenuhnya dilakukan sebelum masuk Antibiotik pada pasien pneumonia sebagai diagnosis sekunder, dikarenakan sudah mendapat terapi Antibiotik sebagai terapi dari diagnosis lainnya.

2. Bronkopneumonia Anak

- a. *Length of Stay* minimal 5 hari untuk pasien dengan diagnosis utama Bronkopneumonia
- b. Analisa penggunaan obat



Tabel 2.1 Perbandingan penggunaan obat sesuai PPK

No	Golongan obat/terapi	PPK	Obat dari DPJP			
			dr Irawan, Sp.A	dr Esti, Sp.A	dr. Ratih, Sp.A	dr. Qashastia, Sp.A
			137819 (2 bln 9 hari) MRS 9-13 April	81085 (2 th) MRS 7-11 April	73618 (2 th) 5-9 April	141948 (2 th) MRS 12-16 April
1	Oksigen	Oksigen	O2 simple mask			
2	Hidrasi Intravena	D5 1/2 NS / D5 1/4 NS 14 tpm	Inf D5 1/4 NS 500 ml	Inf Kaen 3B 500 ml	Inf Kaen 3B 500 ml	Inf Kaen 3B 500 ml
3	Antibiotik	Ceftriaxon 50 - 100 mg/KgBB/hari	Inj Cefotaxime 3x200 mg (dari 10/4)	Inj Ceftriaxone 2x500 mg (dari 8/4)	Inj Ceftriaxone 2x650 mg (dari 5/4)	Inj Ceftriaxone 2x550 mg (dari 12/4)
4	Antipiretik/Analgetik	Santagesik 10 mg/KgBB/K/p	Inf Paracetamol 1 G/100 ml 3x1	Inj Metamizole 1 g/2 ml 3x200mg	Inj Metamizole 1 g/2 ml 3x200mg	Inj Metamizole 1 g/2 ml 3x120mg
						Tab Paracetamol 3x120 mg
5	Antiemetik	Ondancentron 0,1 mg/KgBB/K/p	-	Inj Ondansetron 4 mg/2 ml 3x1mg	Inj Ondansetron 4 mg/2 ml 3x1mg	Inj Ondansetron 8mg/4 ml 3x1mg
6	Bronkodilator	Ventasal 3x1/2 - 1 ampul	Nebul Ventasal 2.5 mg 4x1	Nebul Ventasal 2.5 mg 2x1	Nebul Ventasal 2.5 mg 2x1	Nebul Farbivent 0.5 mg/Pulmicort 0.5 mg 4x1
7	Racikan batuk	Obat batuk sirup atau racikan 3x1	Triamcinolone 4 mg, Ambroxol 30 mg, Salbutamol 2mg (3x1)	Triamcinolone 4 mg, Ambroxol 30 mg, Salbutamol 2mg (3x1)	Triamcinolone 4 mg, Ambroxol 30 mg, Salbutamol 2mg, Tremenza (3x1)	Salbutamol 1 mg, Acetylcysteine 100 mg, Tremenza 1/6 tab (3x1)
8	Obat Pulang	Cefixime 8 mg/KgBB/Hari selama 10 hari / sirup	Syr Cefixim 100 mg/5 ml 2x5 ml	Syr Cotrimoxazole 240 mg/5ml 2x5ml	Puyer Cefixime 2x50 mg	-
		Obat racikan batuk / sirup	Racikan batuk (Triamcinolon, Ambroxol, Salbutamol) 3x1	Racikan batuk (Triamcinolon 1 mg, Ambroxol, Salbutamol 1 mg) 3x1	Racikan batuk (Salbutamol 1mg, triamcinolon 1mg, tremenza 1/4, ambroxol) 3x1	Racikan batuk (Salbutamol 1 mg, Acetylcysteine 100 mg, Tremenza 1/6 tab) 3x1
		-	Syr Paracetamol 120 mg/5 ml 3x5 ml	Syr Paracetamol 120 mg/5 ml 3x5 ml	Puyer Cetirizin 1x6mg	Syr Paracetamol 120 mg/5 ml 3x5 ml
9	Variasi obat lain	-	-	Syr Zamel 60 mL 1x5ml	Inj Ranitidin 1x50 mg	Syr Zincpro 1x5ml

			-	-	Elkana Syr 60ml	Syr Sucralfat 3x2.5 ml
--	--	--	---	---	--------------------	---------------------------

- Tabel diatas diambil dari pasien dengan diagnosis utama Bronkopneumonia pada periode MRS bulan April 2026 secara random sampling.
 - Penggunaan antibiotik injeksi sebagian besar sudah sesuai dengan CP : Injeksi Ceftriaxone selama 5 hari. Namun masih ada durasi pemberian antibiotic injeksi <5 hari, meskipun LOS sudah memenuhi.
 - Terdapat variasi komponen dari racikan batuk.
 - Terdapat penggunaan double analgetik (dr Qashas, Sp.A)
 - Variasi obat lain diluar PPK/CP adalah suplemen (Zamel, Elkana), obat dyspepsia (Ranitidin, Sucralfat), dan Zinc
 - Penggunaan obat didasarkan pada klinis pasien dan keputusan medis DPJP.
- c. Penunjang yang dilakukan adalah Darah Lengkap dan Foto polos Thorax PA. Gambaran radiologi sudah sesuai bacaan Bronkopneumonia

3. Demam Tifoid Dewasa

- a. *Length of Stay* bervariasi antara 3-5 hari untuk pasien dengan diagnosis utama Demam Tifoid pada Dewasa
- b. Analisis pemeriksaan penunjang

Tabel 3.1 Analisis pemeriksaan penunjang Demam Tifoid dewasa

No	Penunjang Sesuai PPK	Penunjang dari DPJP				
		dr. Aditya, Sp.PD	dr. Aji, Sp.PD	dr. Heriyatmo, Sp.PD	dr. Dimas, Sp.PD	dr. Camel, Sp.PD
		142069 MRS 13-17 April	107266 MRS 13-15 April	67675 MRS 27-30 April	142389 MRS 18-22 April	135972 MRS 27-30 April
1	Darah lengkap	Darah lengkap	Darah lengkap	Darah lengkap	Darah lengkap	Darah Lengkap
2	IgM Anti Salmonella	IgM Anti Salmonella	IgM Anti Salmonella	IgM Anti Salmonella	IgM Anti Salmonella	IgM Anti Salmonella
3	Elektrolit	Elektrolit	-	-	Elektrolit	-
4	Variasi Lain	Gula Darah Sewaktu	Gula Darah Sewaktu	Gula Darah Sewaktu	Gula Darah Sewaktu	Gula Darah Sewaktu
		UL Asam Urat	-	UL	SGOT SGPT Kreatinin ureum	GDP GD2JPP HbA1C UL LDL

- Tabel diatas diambil dari pasien dengan diagnosis utama Demam Tifoid pada periode MRS bulan April 2026 secara *random sampling*.
- Pemeriksaan yang rutin dilakukan DPJP adalah Darah lengkap, GDS, dan IgM Salmonella.
- Elektrolit yang ada pada PPK/CP tidak rutin dilakukan pada pasien demam tifoid dewasa.
- Penunjang selain yang ada pada PPK/CP : Fungsi liver, fungsi renal, urin lengkap, profil gula. Pemeriksaan tersebut didasarkan pada kondisi pasien

(menegakkan diagnosis sekunder atau penapisan diagnosis banding) dan berdasarkan keputusan klinis DPJP.

c. Analisis penggunaan obat

Tabel 3.1 Perbandingan penggunaan obat Demam Tifoid dewasa sesuai PPK/CP

No	Golongan obat/terapi	PPK	Obat dari DPJP				
			dr. Aditya, Sp.PD	dr. Aji, Sp.PD	dr. Heriyatmo, Sp.PD	dr. Dimas, Sp.PD	dr. Camel, Sp.PD
			142069 MRS 13-17 April	107266 MRS 13-15 April	67675 MRS 27-30 April	142389 MRS 18-22 April	135972 MRS 27-30 April
1	Hidrasi Intravena	NaCl / RL 1500 ml/24 jam	Inf RL 500 ml	Inf NS 0.9% 500 ml	Inf NS 0.9% 500 ml	Inf NS 0.9% 500 ml	Inf Asering 500 ml
2	Antibiotik	Ceftriaxon 2-4 gr/hari	Inj Ceftriaxone 2x1 g	Inj Ceftriaxone 2x1 g	Inj Ceftriaxone 2x1 g	Inj Ceftriaxone 2x1 g	Inj Ceftriaxone 2x1 g
3	Antiemetik	-	Inj Ondansetron 8mg/4ml 2x1	Inj Ondansetron 8mg/4ml 2x1	Inj Ondansetron 4mg/2ml 1x1	Inj Ondansetron 4mg/2ml 2x1	-
4	Analgetik/ Antipiretik	Paracetamol 3x500 mg	Inj Metamizole 1g/2ml 2x1	Paracetamol tab 500 mg 3x1	Inj Metamizole 1g/2ml 1x1	Inj Metamizole 1g/2ml 3x1	-
5	PPI/H2 blocker/ mucoprotector	a. Lansoprazol / Omeprazol 2x1 b. Sucralfat 3x10 ml	-	Omeprazole caps 2x20 mg	Inj Ranitidin 50 mg/2 ml 1x1	Inj Omeprazole 40 mg 2x1	Inj Omeprazole 40 mg 1x1
6	Obat Pulang	Antibiotik a. Thiamfenikol 4x500 mg/hari selama 7 hari b. Kotrimoksazol 2x(160-800) selama 10 hari c. Ciprofloxacin 2x500 mg selama 7 hari d. Cefixime 2x100 mg selama 5 hari	Cefadroxil 2x500 mg	Levofloxacin 1x750 mg	Cefixime 2x100 mg	Cefixime 2x200 mg	Cefixime 2x200 mg
		Vitamin B Komplek 1x1 selama 5 hari	Elkana 2x1	Omeprazole caps 2x20 mg	Lansoprazole 1x30 mg	Omeprazole 20 mg 2x1	Acarbose 3x50 mg
		Sucrlarfat 3x10 ml	Neurohax 1x1	Neurohax 1x1	Sucralfate syr 500 mg/5ml 3x15ml	Domperidone 20 mg 2x1	Piralen 3x10 mg
		Paracetamol 3x500 mg	Curcuma 2x1	-	Racikan (Domperidon 10 mg, Piralen 10 mf, Braxidin) 2x1	Paracetamol 3x500 mg	-
		-	-	-	-	Prohepar 1x1	-

7	Variasi lain	-	Ericaf tab 3x1	-	Pularex 1x2	Braxidin 3x1	Inj Primperan 3x1
			Inj Calcii Gluconas 100 mg/ml 1x1	-	Levofloxacin 1x750 mg	-	Acarbose 3x50 mg

- Tabel diatas diambil dari pasien dengan diagnosis utama Demam Tifoid pada periode MRS bulan April 2026 secara *random sampling*.
- Penggunaan antibiotik selama rawat inap sudah sesuai dengan PPK/CP : Inj. Ceftriaxone selama 3—5 hari, kemudian dilanjutkan dengan antibiotik per oral saat KRS
- Variasi penggunaan obat diluar PPK/CP : Suplemen (Elkana, Neurohax, Calcii glukonas, Prohepar, Curcuma); Analgetik golongan ergotamine (braxidin), attapulgite (pularex), Acarbose. Obat-obat tersebut diberikan berdasarkan indikasi medis pada pasien dan pertimbangan klinis dari DPJP.

4. Demam Tifoid Anak

- Length of Stay* antara 4—6 hari pada pasien Demam Tifoid anak, belum sepenuhnya sesuai dengan CP 5 hari
- Seluruh DPJP sudah sesuai PPK/CP untuk pemeriksaan penunjang : Darah lengkap dan IgM Anti Salmonella
- Analisis penggunaan obat

Tabel 4.1 Perbandingan penggunaan obat Demam Tifoid anak sesuai PPK/CP

No	Golongan obat/terapi	PPK	Obat dari DPJP			
			dr Irawan, Sp.A	dr Esti, Sp.A	dr. Ratih, Sp.A	dr. Qashastia, Sp.A
			141864 (13 th) MRS 10-14 April	141247 (7 th) MRS 31 Maret - 4 April	78979 (2 th) MRS 14-17 April	141956 (13 th) MRS 12-16 April
1	Hidrasi Intravena	NaCl / RL 1500 ml/24 jam	Inf Kaen 3B 500 ml	Inf D5 1/2 NS 500 ml	Inf Kaen 3B 500 ml	Inf D5 1/2 NS 500 ml
2	Antibiotik	Ceftriaxon 2-4 gr/hari	Inj Ceftriaxone 2x1g (dari 11/4)	Inj Ceftriaxone 2x1g (dari 1/4)	Inj Cefotaxime 3x600 mg (dari 15/4)	Inj Ceftriaxone 2x1g (dari 12/4)
3	Antiemetik	-	Inj Ondansetron 8 mg/4ml 3x3mg	Inj Ondansetron 4mg/2ml 3x1mg	Inj Ondansetron 4 mg/2ml 3x1	-
4	Analgetik/Antipiretik	Paracetamol 3x500 mg	Inj Metamizole 1g/2ml 3x600 mg	Inj Metamizole 1g/2ml 3x400 mg	Inj Metamizole 1g/2ml 3x250 mg	Inj Metamizole 1g/2ml 3x350mg
			-	Puyer Paracetamol 3x250 mg	-	-
5	PPI/H2 blocker/mucoprotector	a. Suclarfat 3x10 ml b. Lansoprazol / Omeprazol 2x1	-	-	-	Sucralfate 500 mg/5 ml 3x7.5 ml



6	Obat Pulang	Antibiotik 1. Thiamfenikol 4x500 mg/hari selama 7 hari 2. Kotrimoksazol 2x(160-800) selama 10 hari 3. Ciprofloxacin 2x500 mg selama 7 hari 4. Cefixime 2x100 mg selama 5 hari	Cefixim tab 200 mg 2x1	Puyer Cefixim 3x50 mg	-	Cefixim 2x100 mg
		Vitamin B Komplek 1x1 selama 5 hari	Omeprazole caps 20 mg 1x1	Puyer Paracetamol 3x250 mg	Puyer Nixaven 2x100 mg	Racikan batuk (Salbutamol, Acetylcystein)3x1
		Suclarfat 3x10 ml		Racikan batuk (Salbutamol, Triamcinolon, Ambroxol, Novacolin) 3x1	Lacto-B 1x1	
		Paracetamol 3x500 mg			Iprox Forte syr 200 mg/60 ml 3x5ml	
7	Variasi lain		-	Puyer Cefixim 3x50 mg saat rawat inap	Inj Mersibion 1x1	Racikan batuk (Paracetamol, Salbutamol, Acetylcysteine) 3x1
			-	-	Zyncpro syr 1x5 ml	-

- Penggunaan antibiotic belum sesuai dengan CP : Inj. Ceftriaxone variatif antara 3—5 hari, Inj Cefotaxime 3 hari
- Tidak semua DPJP memberikan antibiotik oral untuk obat pulang (dr. Ratih, Sp.A)
- Terdapat penggunaan double analgetik saat rawat inap (dr Esti, Sp.A; dr. Ratih, Sp.A)
- Variasi obat selain PPK/CP meliputi racikan batuk, dan suplemen (mesrsibion, zyncpro)
- Variasi obat didasarkan pada klinis pasien dan pertimbangan medis DPJP.

5. Soft Tissue Tumor dengan tindakan eksisi

- Length of Stay* 3 hari untuk pasien dengan diagnosis utama STT tanpa komplikasi
- Kriteria eksisi sudah sesuai : Dimensi >4 cm yang meluas ke struktur vital dan/atau deep tumor dan/atau dengan keganasan
- Antibiotik profilaksis : Cefazolin 2 g atau Pycin 1.5 g (dr Zaki Yamani, Sp.B), tanpa profilaksis (dr Djanuar Sp.B)
- Dilakukan PA pada setiap eksisi STT

- e. Obat anastesi (propofol, etanyl, miloz, dan isoflurane) dan obat pulang (cefixime dan analgesic) sudah sesuai CP

6. DM Gangrene/ulkus dengan Tindakan debridement

- Length of Stay* 3-5 hari untuk Gangrene/ulkus, tergantung pada kondisi umum pasien dan komplikasi penyakit lainnya.
- Antibiotik profilaksis : Cefazolin 2 g (dr. Zaki Yamani, Sp.B dan dr Angga Sp.B); tanpa profilaksis (dr Djanuar, Sp.B)
- Anestesi dilakukan General anestesia atau SAB (dr Angga, Sp.B)
- Antibiotik terapeutik selama rawat inap : Inj Ceftriaxone 2x1 g
- Obat pulang sudah sesuai CP (Cefixime dan analgesik)

7. Dengue Hemorrhagic Fever

- Length of Stay* bervariasi antara 3-4 hari untuk pasien dengan diagnosis utama Dengue Hemorrhagic Fever
- Manifestasi klinis sudah sesuai dengan PNPK dimana ada gejala utama dengue disertai dengan perburukan klinis (nyeri perut, muntah persisten, dehidrasi berat)
- Nilai trombosit sudah sesuai PNPK dengan nilai <150.000 untuk DF dan <100.000 untuk DHF
- Dilakukan pemeriksaan darah lengkap serial untuk observasi nilai trombosit
- Tatalaksana meliputi terapi cairan dan simptomatik

8. Sectio Caesaria

a. Evaluasi Klinis

- Length of Stay* 3 hari
- Penyulit sebagai indikasi SC sudah sesuai : BSC dengan Letak sungsang, BSC dengan letak lintang, oligohidramnion dengan fetal distress

b. Evaluasi Biaya

Tabel 8.1 Evaluasi Biaya SC pasien BPJS Kelas 1

NO	ITEM	INACBG'S		DPJP		
		JUMLAH	HARGA TOTAL	dr. Santoso, Sp.OG	dr. Rudi, Sp.OG	dr. Agung Sp.OG
1	Darah lengkap	-	-	Rp.138.000	Rp.60.000	Rp.138.000
2	Alcohol swab	-	-	Rp.722	Rp.310	Rp.1.135
3	Asam Mefenamat	-	-	Rp.2.912	Rp.2.704	Rp.2.704
4	Blood transfusi set	-	-	Rp.22.633	Rp.22.633	-
5	Cairan inf NS 0.9% 100 ml	1	Rp.7.873	Rp.15.746	Rp.7.873	Rp.7.873
6	Cairan inf RL 500 ml	5	Rp.41.429	Rp.49.714	Rp.58.000	Rp.41.429
7	Cefadroxile caps 500 mg	-	-	Rp.17.654	-	Rp.15.132
8	Dexametason inj 5 mg/ml	-	-	-	Rp.2.625	-
9	Foley cath 2 way no 14	-	-	-	-	Rp.24.470
10	Foley cath no 14	1	Rp.31.746	Rp.31.746	Rp.31.746	-
11	Granisetron inj 3 mg/3ml	-	-	Rp.32.468	-	-
12	Handscoon non steril s - safeglove/onemed	10	Rp.4.030	Rp.9.672	Rp.6.448	Rp.6.448

13	Handscoon non steril xs - safeglove/onemed	-	-	-	Rp.2.418	Rp.4.836
14	IV cannula plus no. 20	-	-	Rp.12.090	Rp.12.090	-
15	Lactamam tab 0.125mg	-	-	-	Rp.16.104	-
16	Masker karet (gidcare/procare/b ayamed)	-	-	Rp.520	Rp.1.040	Rp.1.560
17	Metvell tab 0.125 mg	-	-	Rp.38.465	Rp.35.717	-
18	Oxytocin inj 10 iu/1 ml	-	-	Rp.15.330	Rp.9.198	Rp.9.198
19	Primperan inj	-	-	-	Rp.4.473	Rp.4.473
20	Prohelic caps	-	-	-	-	Rp.83.875
21	Spinocan no. 25	-	-	Rp.40.110	-	-
22	Sput 3 cc	6	Rp.4.452	Rp.6.731	Rp.7.459	Rp.6.719
23	Sput 5 cc	1	Rp.2.538	Rp.2.538	Rp.2.538	Rp.3.356
24	U-pad non steril 60 x 90	3	Rp.10.413	Rp.10.413	Rp.10.413	Rp.13.884
25	Sput 1 cc	-	-	Rp.10.823	-	-
26	Lacto B			-	Rp.22.186	-
	Total biaya	Rp.6.967.500		Rp.8.421.226	Rp.8.241.099	Rp.8.249.353

Tabel 8.2 Evaluasi Biaya SC pasien BPJS Kelas 3

NO	ITEM	INACBG'S		DPJP	
		Jumlah	Harga Total	dr. Santoso, Sp.OG	dr. Rudi, Sp.OG
1	NST	-	-	Rp.40.250	Rp.86.250
2	Darah lengkap	-	-	Rp.129.000	Rp.60.000
3	Alcohol swab	-	-	Rp.825	Rp.1.238
4	Asam Mefenamat	-	-	Rp.2.496	Rp.2.288
5	Blood transfusi set	-	-	Rp.22.633	Rp.22.645
6	Film island dressing 10x25 cm	-	-	Rp.24.964	Rp.24.964
7	Cairan inf RL 500 ml	5	Rp41.429	Rp.82.857	Rp.66.286
8	Cefadroxile caps 500 mg	-	-	Rp.15.132	-
9	Dexametason inj 5 mg/ml	-	-	-	Rp.2.625
10	Foley cath 2 way no 14	-	-	-	Rp.24.470
11	Foley cath no 14	1	Rp31.746	Rp.31.746	-
12	Gentamicin inj 40 mg/ml	-	-	Rp.4.762	-
13	Handscoon non steril s - safeglove/onemed	10	Rp4.030	Rp.7.254	Rp.8.978
14	Handscoon non steril xs - safeglove/onemed	-	-	Rp.2.418	Rp.2.418
15	Ranitidine inj 50mg/2ml	1	Rp1.732	Rp.1.732	Rp.3.464
16	Metamizole inj 1 g/2 ml	-	-	Rp.16.640	Rp.16.640
17	IV cannula plus no. 18	-	-	Rp.12.090	Rp.12.090

18	Lactamam tab 0.125mg	-	-	-	Rp.26.840
19	Masker karet (gidcare/procare/baymed)	-	-	Rp.780	Rp.1.300
20	Metvell tab 0.125 mg	-	-	Rp.32.970	Rp.30.222
21	Oxytocin inj 10 iu/1 ml	-	-	Rp1.5.330	Rp.9.198
22	Primperan inj	-	-	Rp.4.473	RP.4.473
23	Sput 3 cc	6	Rp.4.452	Rp.8.215	Rp.7.459
	Total biaya	5.238.800		6.810.625	6.747.593

Analisa :

- Table diatas diambil dari kasus diagnosis utama *Sectio Caesaria* (SC) pada SMF Obstetri dan Ginekologi periode bulan pelayanan Maret 2026 secara *random sampling*. Diagnosis sekunder variatif, namun tidak mempengaruhi plafon INACBG's pada kasus diatas
- Berdasarkan hasil tabel diatas nilai selisih paling tinggi rata-rata adalah dr. Santoso Rahardjo, Sp.OG. Dimana hasil selisih terbesar didapatkan dari penggunaan BHP (Spinocan 25, Sput 1 cc) dan obat (Granisetron) pada peserta BPJS kelas 1 yang tidak digunakan dokter lainnya, serta perbedaan jumlah penggunaan obat (cefadroxil, gentamisin, oxytocin) pada peserta BPJS kelas 3
- Terdapat pemberian obat-obatan yang tidak ada dalam paket INACBG's : Asam Mefenamat, Cefadroxile caps 500 mg, Dexametason inj 5 mg/ml, Granisetron inj 3 mg/3ml, Lactamam tab 0.125 mg, Metvell tab 0.125 mg, Oxytocin inj 10 iu/1 ml, Primperan inj, Prohelic caps, Lacto B. Dimana penggunaan obat didasarkan pada kondisi klinis pasien dan keputusan medis DPJP.
- Terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis BHP yang ada dalam paket INACBG's : Foley catheter, Masker, Handscoon, Sput, Dressing
- Terdapat perbedaan tarif penunjang (darah lengkap, NST). Ada yang dilakukan 1x di IGD, ada yang diulang di ruangan rawat inap sedangkan harga tarif antara IGD dan rawat inap berbeda.

C. TINDAKLANJUT

- Review PPK CP
- Sosialisasi PPK CP baru
- Audit Kepatuhan PPK CP setelah di review

Pasuruan, 08 Mei 2026
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Heni Indra Wulansari, S.Kep.Ns, M.Kep